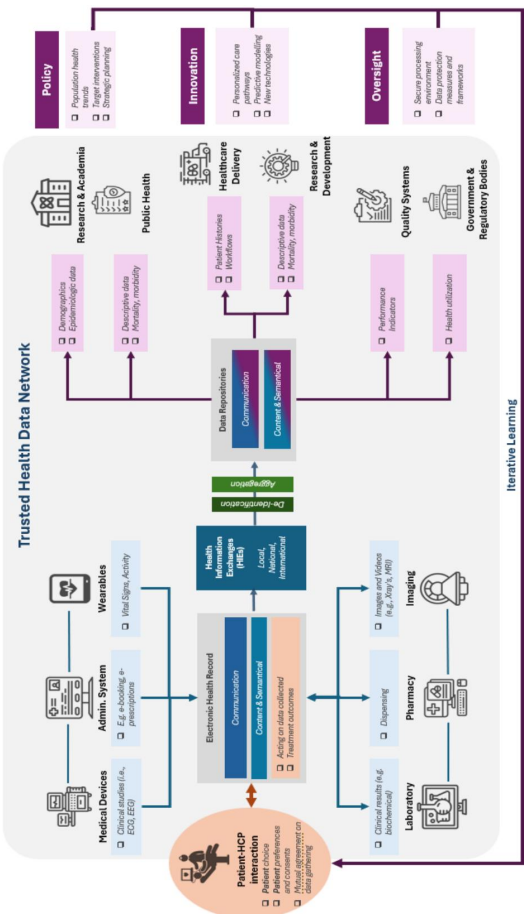


KC桌面——外资精译

经合组织：医疗健康互操作性障碍与路径

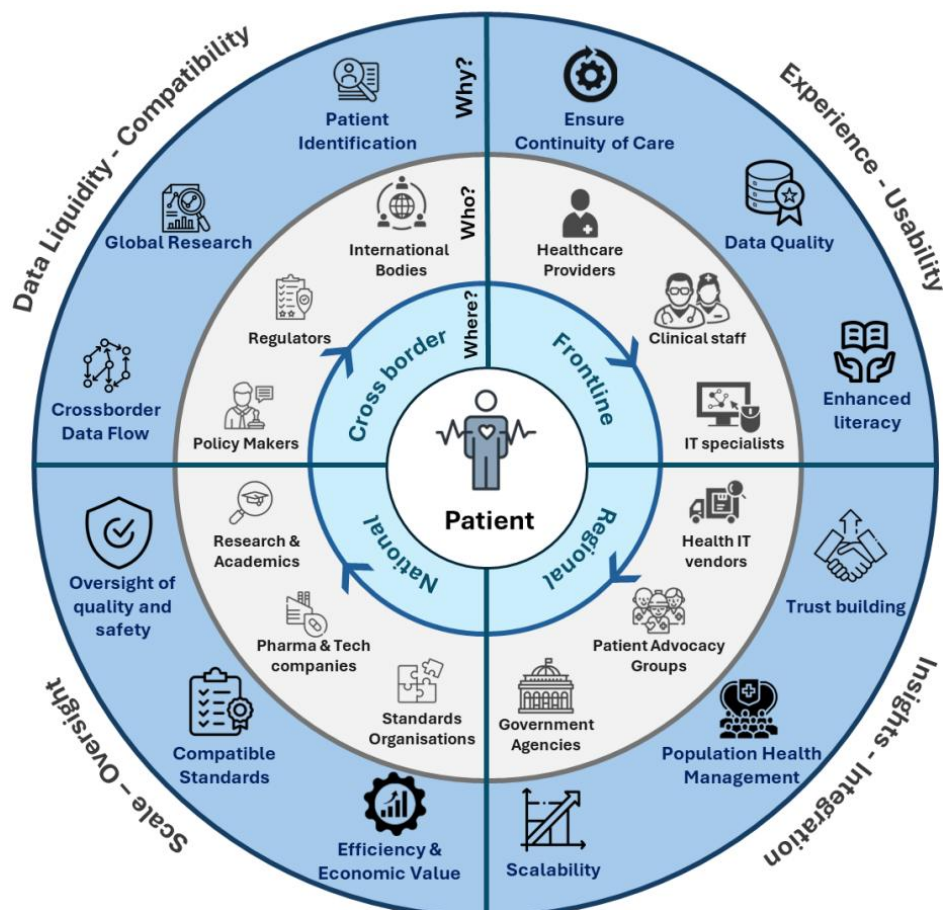
OECD最新工作论文指出，医疗健康互操作性——即不同系统、设备或组织之间安全交换、解释和使用数据的能力——长期被列为卫生系统数字化的核心目标，但至今仍未充分实现。报告基于41次专家访谈、22国调查回复及多轮专家咨询，系统梳理了互操作性在人员、政策、流程和技术四个层面的障碍与领先实践。据加拿大、芬兰和英国的报告估算，实现医疗数据互操作性可带来的潜在价值相当于卫生支出的2.7%至6.6%，这一价值通过优化服务交付、减少错误、更及时的治疗、加速研发和预防措施来实现。



图表 1

互操作性障碍集中在数据共享实践、基础设施碎片化和治理协调不足

受访专家指出的最普遍障碍包括：不兼容的数据共享实践和去标识化操作不一致（70.59%）、跨区域基础设施和技术碎片化（66.67%），以及治理和机构协调碎片化（60.78%）。报告还发现，诊断错误约占医疗成本的17.5%，其中一部分可归因于互操作性不足；当患者被要求重复提供信息时，对卫生系统的信任度下降15%；81.5%的医生认为互操作性不足对患者安全构成潜在不确定性。在技术层面，所有受访国家都在使用健康数据标准，其中41%仅依赖国际标准，但仅有27%的受访国家完全实施了评估和确保健康数据收集质量的程序，23%完全实施了重要健康数据资产的编目程序。



图表 2

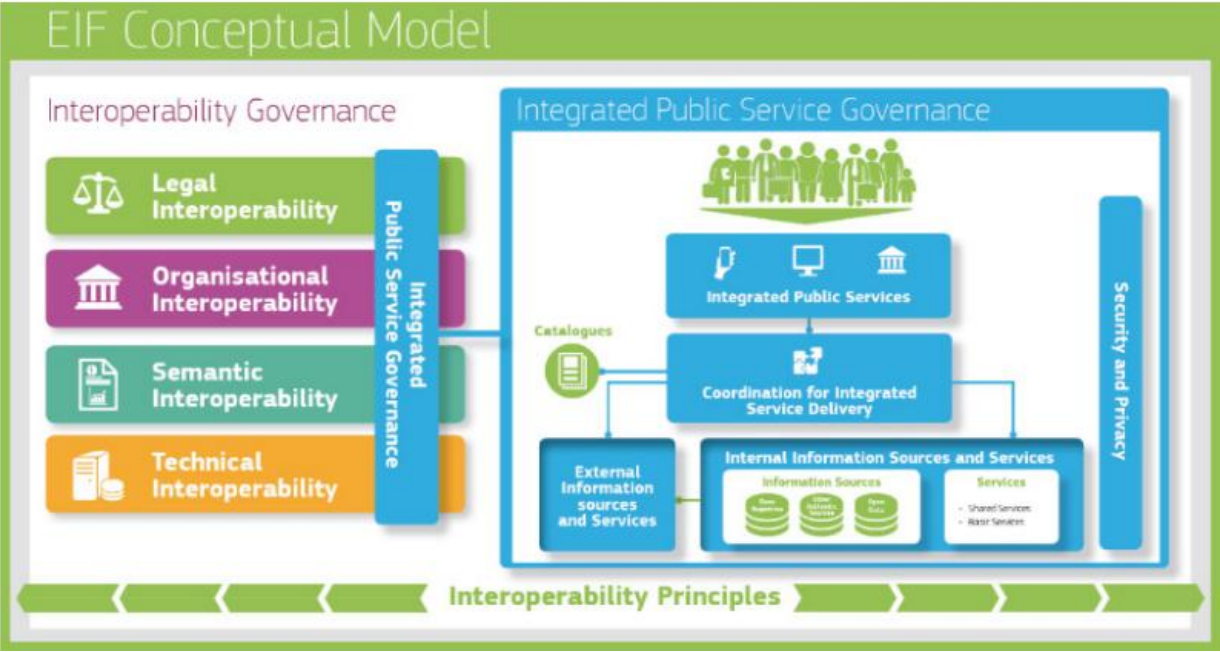
政策框架建设滞后，仅23%受访国家立法强制基于标准的数据交换

报告识别出26项政策推动因素，分布在人员、流程、政策和技术四个领域，并按照本地医疗机构、区域、国家和跨境四个数据交换层级进行评估。在政策层面，仅有23%的受访国家报告已立法强制基于标准的健康数据交换。32%的国家已实施健康数据标准采纳的国家战略或路线图，50%设有负责标准采纳和使用的国家机构，55%通过国家流程或立法影响供应商对互操作性要求的合规性。跨境数据交换正在增加，45%的国家参与双边国际合作，75%已建立可信健康数据网络。报告特别提到欧盟健康数据空间、芬兰健康和社会数据二次利用法案、美国21世纪治愈法案等正在加强跨境数据共享、数据二次利用和防止数据封锁的政策框架。

> KC评论：政策框架的滞后是互操作性推进的核心瓶颈。仅有不到四分之一的国家通过立法强制标准采纳，这意味着多数国家的互操作性仍依赖自愿性安排，难以形成系统性的数据流通基础。

人员和文化因素成为互操作性实现的关键突破口

报告强调，虽然技术和语义层面的挑战历来被优先处理，但互操作性本质上是一个人员和文化问题。受访专家将现代化互操作性基础设施（70.83%）、通过共享存储库标准化数据集和词汇（64.58%）、加强跨境和跨利益相关方协作（60.42%）、推进法律框架以支持国际数据共享和使用（60.42%）列为最优先事项。法国和丹麦通过透明的公民参与和数据使用实践增强公众信任，澳大利亚则研究于以人为中心的国家标准制定和采纳方法。报告认为，实现互操作性的路径应从共享思维模式开始，发展到必要的技能组合，再到部署适当的工具集，最终建立以患者为中心的集成数字健康生态系统，使数据能够沿着护理连续体跟随患者，并在保护措施下及时为公共利益进行二次利用。



图表 3